UN CAZ PE SĂPTĂMÂNĂ™ · MATERIAL PRINCIPAL

Program de practică clinică de 52 de săptămâni

Un an, o temă pe săptămână. În fiecare săptămână, un singur obiectiv, un capitol de citit din Manual, un caz clinic de exercițiu și o autoevaluare cu trei întrebări. Pentru ca sistemul să nu rămână doar în carte, ci să devină un reflex la scaun.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să folosești acest program

Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei · Săptămânile 1–5

Modulul 02 · Diagnosticul Complet · Săptămânile 6–11

Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică · Săptămânile 12–16

Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi · Săptămânile 17–23

Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III · Săptămânile 24–31

Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale · Săptămânile 32–38

Modulul 07 · Mecanici Complementare · Săptămânile 39–43

Modulul 08 · Finisare și Stabilitate · Săptămânile 44–48

Modulul 09 · Cazuri Clinice Comentate · Săptămânile 49–52

Pasul următor

Personalizează-ți programul

- Ordinea respectă cele 9 module ale Manualului. Dacă în această săptămână ai întâlnit o temă specifică, poți devansa acea săptămână.
- În săptămânile aglomerate, rezolvă doar cazul; lectura și întrebările le poți amâna pentru săptămâna următoare, dar nu întrerupe programul.
- Înainte de a ajunge la cazurile comentate (săptămânile 49–52), recuperează săptămânile omise.
- Marchează progresul pe fișa de monitorizare săptămânală. Pentru obiectivele lunare, consultă planul de dezvoltare clinică pe 12 luni.

ÎNCEPUT

Cum să folosești acest program

În total 30–40 de minute pe săptămână; suficient de scurt pentru a fi împărțit în pauzele dintre doi pacienți.

> *Un sistem nu devine reflex printr-o singură lectură lungă, ci prin repetiția scurtă, efectuată în fiecare săptămână în aceeași ordine.*

Ritmul săptămânal

CÂND	DURATĂ	CE FACI
Prima zi a săptămânii	10–15 minute	Citește obiectivul. Deschide secțiunea relevantă din Manual și hărțile vizuale.
Mijlocul săptămânii	10 minute	Rezolvă cazul săptămânii fără a privi comentariul. Scrie răspunsul în spațiul alocat, apoi citește comentariul.
Ultima zi a săptămânii	5–10 minute	Răspunde la cele trei întrebări și compară-le cu răspunsurile scurte. Bifează pe fișa de monitorizare.
În timpul consultației	—	Dacă ai un pacient care se potrivește temei săptămânii, pune aceleași întrebări și în cazul lui.

Aceiași 4 pași pentru fiecare caz

1. **Citește datele.** Vârstă, profil, relație molară și canină, overjet și overbite, valori cefalometrice, obiceiuri vicioase.
2. **Scrie lista de probleme.** Clasifică pe plan sagital, vertical, transversal și probleme de spațiu.
3. **Notează decizia cu argumentație.** O singură frază: ce faci și de ce.
4. **Compară cu comentariul.** Dacă ai gândit diferit, revino la harta vizuală și notează într-un rând diferența.

Cazurile au scop educațional

Datele cazurilor sunt fictive și simplificate în scop pedagogic. La un pacient real, decizia se ia întotdeauna pe baza unui examen complet și a documentației. Eticheta de **Bază**, **Intermediar** sau **Avansat** din colțul dreapta sus al cazului indică dificultatea; în cazurile avansate, este absolut normal să nu ai exact aceeași opinie ca în comentariu: scopul este construirea raționamentului.

MODULUL 01 · SĂPTĂMÂNILE 1–5

Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei

Această secțiune cuprinde 5 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 1 din Manualul Ortodontului.

Săptămâna 1

Clasificarea Angle și tipurile de malocluzii

Modulul 01

Scopul săptămânii	Să descrii la fiecare pacient nou, în 30 de secunde, separat pe ambele părți și folosind terminologia corectă, relația molară și canină.
Citește în Manual	Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei
Hărți vizuale	Harta vizuală 1 (Clasificarea Angle) · Harta vizuală 2 (Tipurile de malocluzii)

Cazul săptămânii

BAZĂ

Pacientă de 14 ani. Relație molară de Clasa II completă pe partea dreaptă și stângă, relație canină de Clasa II. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. Incisivii superiori sunt proclinați. În repaus, buzele nu sunt în contact.

Întrebare: Descrie clasa Angle și subdiviziunea. Ce nu ne spune această informație prin ea însăși?

Comentariu: Clasa II subdiviziunea 1: overjet mărit și incisivi superiori proclinați. Clasificarea Angle descrie doar relația sagitală a dinților; originea osoasă (maxilară sau mandibulară) și tiparul vertical nu sunt incluse. Acestea se diferențiază pe baza cefalometriei și a profilului clinic.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Pe ce relație se bazează clasificarea Angle?
2. Care este caracteristica incisivilor în Clasa II subdiviziunea 2?
3. Ce notezi dacă relația molară diferă între partea dreaptă și cea stângă?

Răspunsuri scurte: 1. Poziția cuspizilor mezio-vestibulari ai molarului prim superior față de șanțul vestibular al molarului prim inferior. **2.** Centrali superiori retroclinați (adesea cu laterali proclinați) și ocluzie adâncă. **3.** Descrii separat fiecare parte (ex. Clasa I pe dreapta, Clasa II jumătate de unitate pe stânga) și cauți cauza asimetriei.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 2

Cele 6 chei ale ocluziei

Modulul 01

Scopul săptămânii	Privind un caz aflat în faza de finisare, să identifici rapid care dintre cele șase chei lipsește.
Citește în Manual	Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei
Hărți vizuale	Harta vizuală 7 (Cele 6 chei ale ocluziei)

Cazul săptămânii

BAZĂ

Luna 18 de tratament, control de finisare. Relația molară este de Clasa I pe ambele părți. Nu există spații între incisivi. Premolarii secunzi superiori prezintă o rotație marcată. Curba Spee inferioară este încă adâncă de cca. 3 mm.

Întrebare: Dintre cele șase chei, care nu sunt încă îndeplinite?

Comentariu: Lipsesc absența rotațiilor (cheia 4) și planul de ocluzie plat sau ușor curbat (cheia 6). Premolarul rotat ocupă mai mult spațiu în arcadă și compromite contactele; curba Spee adâncă pregătește terenul pentru recidiva ocluziei adânci.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră cele șase chei în ordine.
2. Cheia 1 înseamnă doar clasa molară?
3. De ce cauzează probleme curba Spee adâncă la finisare?

Răspunsuri scurte: 1. Relația molară, angularea coroanei (tip), înclinarea coroanei (torque), absența rotațiilor, puncte de contact strânse, plan de ocluzie plat. **2.** Nu. Este de asemenea necesar ca creasta marginală distală a molarului prim superior să fie în contact cu creasta marginală mezială a molarului secund inferior. **3.** Reduce spațiul necesar pentru poziționarea dinților superiori și menține tendința către ocluzie adâncă.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 3

Creșterea și etapele dentiției

Modulul 01

Scopul săptămânii	Să diferențiezi dacă un diagnostic în dentiția mixtă este o dezvoltare normală sau o problemă care necesită intervenție.
Citește în Manual	Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei
Hărți vizuale	Harta vizuală 8 (Creșterea cranio-facială) · Harta vizuală 21 (Cronologia erupției dentare) · Harta vizuală 22 (Dentiția temporară: aspecte normale) · Harta vizuală 23 (Dentiția mixtă și spațiul Leeway)

Cazul săptămânii

BAZĂ

Băiat de 8 ani. Incisivii inferiori permanenți au erupt, există o înghesuire de aproximativ 2 mm la nivelul incisivilor inferiori. Caninii și molarii temporari sunt prezenți, fără carii. Relația molară este de Clasa I.

Întrebare: Este necesar un tratament imediat? Pe baza căror informații decizi?

Comentariu: În dentiția mixtă timpurie, înghesuirile ușoare ale incisivilor inferiori sunt frecvente. Efectuăm analiza spațiului, evaluăm spațiul Leeway și menținerea molarilor temporari; planificăm monitorizarea periodică. Dacă există riscul pierderii de spațiu, menținerea spațiului Leeway (de ex. arc lingual) poate fi luată în considerare ca opțiune.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Ce este spațiul Leeway?
2. Unde se află spațiile primate?
3. Cu ce documentație apreciezi proximitatea vârfului de creștere?

Răspunsuri scurte: 1. Diferența dintre suma meziodistală a caninului și molarilor temporari și suma dinților permanenți care le iau locul. **2.** Superior între incisivul lateral temporar și caninul temporar, inferior între caninul temporar și primul molar temporar. **3.** Maturitatea vertebrelor cervicale (pe radiografia cefalometrică laterală) sau radiografia de mână-pumn; împreună cu anamneza creșterii în înălțime.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 4

Biomecanică: forță, moment și tipuri de mișcări

Modulul 01

Scopul săptămânii	Explicarea motivului pentru care o mișcare dentară are loc într-un mod nedorit, cu ajutorul centrului de rezistență și al raportului moment/forță.
Citește în Manual	Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei
Hărți vizuale	Harta vizuală 24 (Biomecanică: forță și moment) · Harta vizuală 25 (Tipuri de mișcări dentare) · Harta vizuală 26 (Intensitatea forței și viteza de mișcare)

Cazul săptămânii

MEDIU

Caz cu extracția primilor premolari superiori. În timpul distalizării caninului, coroana caninului se înclină distal, iar rădăcina rămâne mezial. Se utilizează un arc subțire, rotund, iar forța acționează asupra coroanei.

Întrebare: Cum se numește această mișcare și de ce apare? Ce vei modifica?

Comentariu: Înclinare necontrolată (tipping). Forța acționează în direcție coronară față de centrul de rezistență, iar momentul opus este insuficient (raport M/F scăzut). Ne apropiem de o mișcare controlată folosind un arc mai rigid care umple mai bine slotul, forțe reduse și un moment anti-tip suficient.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Ce este centrul de rezistență?
2. De ce este nevoie pentru translație?
3. Care este diferența dintre înclinarea controlată și cea necontrolată?

Răspunsuri scurte: 1. Punctul prin care, dacă trece forța, dintele se deplasează fără rotație (prin translație). **2.** Un moment opus suficient care să echilibreze momentul creat de forță, adică un raport M/F mai ridicat. **3.** În înclinarea controlată, centrul de rotație este aproape de apexul radicular; în cea necontrolată, rădăcina se mișcă în direcția opusă.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 5

Răspuns tisular, rezorbție radiculară, bracketi și secvența arcurilor

Modulul 01

Scopul săptămânii	Recunoașterea și documentarea riscului de rezorbție radiculară înainte de tratament și explicarea logicii secvenței arcurilor.
Citește în Manual	Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei
Hărți vizuale	Harta vizuală 27 (Riscul de rezorbție radiculară) · Harta vizuală 28 (Ligamentul parodontal și remodelarea osoasă) · Harta vizuală 29 (Prescripția bracketului: torque, tip și offset) · Harta vizuală 30 (Materiale pentru arcuri și secvența arcurilor)

Cazul săptămânii

MEDIU

Femeie de 22 de ani. A mai beneficiat anterior de tratament ortodontic. Pe radiografia panoramică, rădăcinile incisivilor superiori par scurte și rotunjite. Noua sa problemă este înghesuirile incisivilor inferiori.

Întrebare: Ce faci înainte de începerea tratamentului?

Comentariu: Notează constatarea în documentația inițială și informează pacientul. Planifică obiective limitate, forțe mici, evitarea mișcărilor radiculare inutile și control radiologic pe parcursul tratamentului. Dacă este disponibil, solicită documentația tratamentului anterior.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră doi factori de risc pentru rezorbția radiculară.
2. Care este logica generală a secvenței arcurilor?
3. În ce fază este util TMA?

Răspunsuri scurte: 1. Forță mare sau prelungită, timp de tratament îndelungat, rezorbție anterioară, morfologie radiculară subțire sau ascuțită, traumatism în anamneză. **2.** Nivelare cu NiTi flexibil, apoi arcuri cu secțiune mai mare, iar la final arcuri cu secțiune dreptunghiulară (adesea din oțel) pentru faza de lucru și finisare. **3.** Deoarece este mai flexibil decât oțelul și mai modelabil decât NiTi, este util în buclele de finisare și în fazele care necesită forțe medii.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

MODULUL 02 · SĂPTĂMÂNILE 6–11

Diagnostic Complet

Această secțiune cuprinde 6 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 02 din Manualul Ortodontului.

Săptămâna 6

Anamneză și examen extraoral: profil și simetrie

Modulul 02

Scopul săptămânii	Să notezi anamneza, profilul și constatările privind simetria în aceeași ordine și fără omisiuni la fiecare prim consult.
Citește în Manual	Modulul 02 · Diagnostic Complet
Hărți vizuale	Harta vizuală 31 (Anamneză ortodontică) · Harta vizuală 32 (Examen extraoral: profil) · Harta vizuală 33 (Simetria facială)

Cazul săptămânii

BAZĂ

Pacientă de 16 ani. Profil convex, mandibulă retrognată. În repaus, buzele nu sunt în contact, iar la închidere se observă contracția mușchiului mentalis. Din vedere frontală, fața este simetrică. Anamneza generală nu relevă probleme cunoscute.

Întrebare: Ce evaluare preliminară notezi pe baza acestor date și prin ce o confirmi?

Comentariu: Profilul convex și mandibula retrognată indică o retruzie mandibulară. Incompetența labială poate fi asociată cu proclinația incisivilor sau cu un exces vertical. Confirmăm prin cefalometrie (SNB, ANB, FMA) și constatări intraorale.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră trei puncte care nu trebuie să lipsească din anamneză.
2. În ce trei tipuri poate fi clasificat profilul?
3. Cum verifici simetria facială?

Răspunsuri scurte: 1. Starea generală de sănătate și medicația, antecedente traumatice, obiceiuri vicioase, dureri ATM, anamneza de creștere și familială. **2.** Drept, convex și concav. **3.** Pacientul în vedere frontală, în poziție naturală a capului: evaluăm linia mediană a feței, mentonul și liniile mediane dentare împreună; în caz de dubiu, documentăm cu fotografii.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 7

Analiza zâmbetului și examenul intraoral

Modulul 02

Scopul săptămânii	Să observi semnele verticale și transversale în timpul analizei zâmbetului și a examenului intraoral.
Citește în Manual	Modulul 02 · Diagnostic Complet
Hărți vizuale	Harta vizuală 34 (Analiza zâmbetului) · Harta vizuală 35 (Examen intraoral)

Cazul săptămânii

MEDIU

Pacientă de 25 de ani. La zâmbet, o parte semnificativă a gingiei superioare este vizibilă. În repaus, vizibilitatea incisivilor superiori este excesivă. Lungimea buzei superioare pare normală clinic. Coroanele incisivilor au lungime normală.

Întrebare: Care sunt cauzele posibile ale zâmbetului gingival? În acest tablou, care predomină?

Comentariu: Cauze posibile: exces vertical de maxilar, extruzia incisivilor superiori, buză superioară scurtă sau hiperactivă, erupție pasivă. Deoarece lungimea buzei și a coroanelor este normală, excesul vertical de maxilar sau extruzia dentoalveolară devin prioritare; evaluăm prin cefalometrie.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. De ce este importantă vizibilitatea incisivilor superiori în repaus?
2. Cum documentezi liniile mediane?
3. Enumeră cinci aspecte din examenul intraoral.

Răspunsuri scurte: 1. În cazul ocluziei adânci, influențează direct decizia privind intruzia și evaluarea tiparului vertical. **2.** Liniile mediane dentare superioară și inferioară separat, în raport cu linia mediană a feței, la dreapta sau la stânga și în mm. **3.** Igiena orală și gingia, dinți lipsă sau supranumerari, înghesuire și spații, relații de ocluzie (în trei dimensiuni), restaurări și carii.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 8

Examen funcțional: ATM, deschiderea gurii și derapaj funcțional

Modulul 02

Scopul săptămânii	Să transformi în rutină verificarea diferenței dintre relația centrică și ocluzia centrică la fiecare pacient.
Citește în Manual	Modulul 02 · Diagnostic Complet
Hărți vizuale	Harta vizuală 36 (Examen funcțional: ATM și deschiderea gurii) · Harta vizuală 89 (Derapaj funcțional)

Cazul săptămânii

MEDIU

Pacientă de 9 ani. În ocluzie centrică se observă o ocluzie inversă laterală dreapta și devierea liniei mediane inferioare spre dreapta. Ghidând mandibula în relație centrică, liniile mediane coincid, iar posterior se observă contact cuspide-pe-cuspide.

Întrebare: Care este diagnosticul tău? De ce este recomandată abordarea timpurie?

Comentariu: Derivare funcțională cauzată de îngustarea maxilarului. Cât timp persistă această derivare, se dezvoltă un obicei de închidere asimetrică și riscul unei asimetrii fixate prin creștere. Evaluează precoce corecția transversală a maxilarului.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Cum verifici diferența CR–CO?
2. Enumeră trei constatări pe care le notezi la examinarea ATM.
3. Care este constatarea principală care diferențiază derivarea funcțională de asimetria reală?

Răspunsuri scurte: 1. Cu pacientul relaxat, ghidând ușor mandibula, observi primul punct de contact și direcția derivării. **2.** Gradul deschiderii gurii, deviația sau deflexia la deschidere, zgomote articulare, sensibilitate la palpare. **3.** Liniile mediene se aliniază în relație centrică.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 9

Analiza pe modele, analiza spațiului și Bolton

Modulul 02

Scopul săptămânii	Calcularea necesarului de spațiu pe arcadă împreună cu curba Spee și poziția incisivilor.
Citește în Manual	Modulul 02 · Diagnostic Complet
Hărți vizuale	Harta vizuală 37 (Analiza pe modele) · Harta vizuală 38 (Analiza Bolton) · Harta vizuală 18 (Analiza spațiului)

Cazul săptămânii

MEDIU

Pacient de 15 ani, Clasa I. În arcada inferioară, suma mezio-distală a dinților este de 72 mm, lungimea arcadei disponibile este de 66 mm. Curba Spee inferioară este de 2,5 mm. Înclinarea incisivilor inferiori este normală, profilul este drept.

Întrebare: Care este gradul înghesuirii în arcada inferioară? Cum interpretezi necesarul total de spațiu?

Comentariu: Înghesuirea este de 6 mm (medie). Corecția curbei Spee necesită, de asemenea, spațiu suplimentar, deci necesarul total este mai mare de 6 mm. Deoarece profilul este drept și înclinarea incisivilor este normală, trebuie luat în calcul faptul că se poate câștiga spațiu limitat prin proclinarea incisivilor.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Ce măsoară analiza Bolton?
2. Care sunt cei doi factori care sunt uitați cel mai frecvent în analiza spațiului?
3. Ce clasificare se folosește frecvent pentru severitatea înghesuirii?

Răspunsuri scurte: 1. Raportul dintre dimensiunile mezio-distale ale dinților superiori și inferiori (anterior și total). **2.** Corecția curbei Spee și poziția planificată a incisivilor. **3.** Până la cca. 4 mm ușoară, 4–8 mm medie, peste 8 mm severă; ia ca referință valorile limită utilizate în cabinetul tău.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 10

Interpretarea radiografiei panoramice și caninii incluși

Modulul 02

Scopul săptămânii	Interpretarea radiografiei panoramice mereu în aceeași ordine și detectarea precoce a riscului de retenție a caninului.
Citește în Manual	Modulul 02 · Diagnostic Complet
Hărți vizuale	Harta vizuală 39 (Interpretarea radiografiei panoramice) · Harta vizuală 17 (Canini incluși)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat de 11 ani. Caninul superior stâng nu este palpabil vestibular, cel drept este. Pe radiografia panoramică, coroana caninului superior stâng acoperă rădăcina incisivului lateral. Caninul temporar este pe arcadă și nu prezintă mobilitate.

Întrebare: Ce indică această constatare? Care sunt pașii tăi următori?

Comentariu: Risc de retenție canină. Rădăcina incisivului lateral trebuie evaluată cu atenție pentru resorbție. Pentru clarificarea poziției, luăm în considerare indicația unei investigații imagistice suplimentare (3D, dacă este necesar). Ca intervenție precoce, se poate lua în calcul extracția caninului temporar; decizia depinde de poziție și de condițiile de spațiu.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care ar trebui să fie ordinea sistematică de interpretare a radiografiei panoramice?
2. De la ce vârstă are sens palparea caninului?
3. În cazul unui canin inclus, care structură vecină trebuie verificată neapărat?

Răspunsuri scurte: 1. Mai întâi structura generală și simetria, apoi osul și sinusurile, apoi numărul dinților, dezvoltarea, rădăcinile și patologia; mereu în aceeași ordine (Instrumentul 1). **2.** De la cca. 10 ani; absența palpabilității unilaterale este un semn de alarmă. **3.** Rădăcina incisivului lateral (și, dacă este necesar, a celui central), pentru a verifica resorbția.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 11

Cefalometrie laterală: Analiza Steiner și tiparul vertical

Modulul 02

Scopul săptămânii	Sintetizarea unui set de valori cefalometrice în trei fraze: sagital, vertical și dentar.
Citește în Manual	Modulul 02 · Diagnostic Complet
Hărți vizuale	40. Hartă Vizuală (Cefalometrie laterală: puncte și planuri) · 41. Hartă Vizuală (Analiza Steiner: SNA, SNB, ANB) · 42. Hartă Vizuală (Tipar vertical: FMA și SN-GoMe) · 3. Hartă Vizuală (Analiză cefalometrică)

Un Caz pe Săptămână™ MEDIU

Pacientă, 13 ani. SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°, FMA 32°, IMPA 98°. Clinic: profil convex și overjet mărit.

Întrebare: Interpretează aceste valori în trei fraze.

Comentariu: Sagital: Clasa II osoasă prin retrognatism mandibular (SNA normal, SNB scăzut). Vertical: FMA peste valoarea normală, tendință hiperdivergentă. Dentar: incisivii inferiori sunt proclinați, compensare dentoalveolară pentru Clasa II.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este valoarea normă frecvent utilizată pentru ANB?
2. Care este valoarea normă clasică pentru FMA?
3. Când poate fi înșelător ANB? Cu ce îl completezi?

Răspunsuri scurte: 1. Aprox. 2° ± 2°. **2.** Aprox. 25°. **3.** Dacă înclinația planului SN sau poziția nasionului este atipică; completăm cu evaluarea Wits și profilul clinic.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

MODULUL 03 · SĂPTĂMÂNILE 12–16

Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică

Această secțiune cuprinde 5 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 03 din Manualul Ortodontului.

Săptămâna 12

Lista de probleme și priorități

Modulul 03

Scopul săptămânii	Să redactezi și să prioritizezi lista de probleme a unui caz, conform aspectelor sagitale, verticale, transversale și de spațiu.
Citește în Manual	Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică
Hărți vizuale	43. Hartă Vizuală (Listă de probleme) · 44. Hartă Vizuală (Prioritizarea obiectivelor tratamentului) · 19. Hartă Vizuală (Planificare ortodontică)

Un Caz pe Săptămână™

MEDIU

Pacient, 13 ani. Clasa II diviziunea 1, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Înghesuire de 4 mm sus și 3 mm jos. Incompetență labială. Acuzația pacientului: „Dinții mei sunt prea în față."

Întrebare: Redactează lista de probleme conform celor patru criterii și stabilește prioritățile.

Comentariu: Sagital: overjet mărit, relație molară de Clasa II. Vertical: ocluzie adâncă. Transversal: fără probleme majore (de verificat). Spațiu: înghesuire 4 mm sus, 3 mm jos. Prioritate: problema sagitală, corelată cu acuzația pacientului și riscul de traumatism; perioada de creștere oferă oportunități. Ocluzia adâncă se planifică împreună cu corecția sagitală.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. După ce criterii redactăm lista de probleme?
2. Unde se plasează acuzația pacientului pe listă?
3. Care este diferența dintre obiectiv și mecanică?

Răspunsuri scurte: 1. Sagital, vertical, transversal, spațiu (înghesuire/spațiere) și acuzația pacientului; dacă e cazul, note parodontale și funcționale. **2.** Separat, într-un rând vizibil; unul dintre obiectivele tratamentului trebuie să răspundă obligatoriu acestei acuzații. **3.** Obiectivul indică ce se schimbă; mecanica indică ce aparat și ce forțe folosim; mecanica se alege după stabilirea obiectivului.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 13

Devreme sau mai târziu? Decizii în perioada de creștere

Modulul 03

Scopul săptămânii	Să diferențiezi situațiile în care tratamentul precoce este cu adevărat avantajos de cele în care este mai corect să aștepți.
Citește în Manual	Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică
Hărți vizuale	45. Hartă Vizuală (Tratament precoce sau tardiv?) · 91. Hartă Vizuală (Maturitatea suturilor și vârsta)

Un Caz pe Săptămână™

MEDIU

Pacientă, 8 ani. Incisivul central superior drept în ocluzie inversă, ceilalți incisivi normali. În relație centrică, incisivul poate fi adus în poziție cap la cap. Pe gingia labială a incisivului inferior a început o ușoară recesiune.

Întrebare: Există indicație pentru tratament precoce? Care este argumentația ta?

Comentariu: Da. Ocluzia inversă frontală care afectează un singur incisiv, devierea funcțională și semnele de solicitare parodontală pe incisivul inferior sunt motive clasice pentru corecția precoce. Dacă spațiul este suficient, luăm în calcul corecția printr-o mecanică scurtă și simplă.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră trei indicații clasice pentru tratamentul precoce.
2. Când este mai corect să aștepți?
3. De ce este important vârful de creștere în tratamentul Clasei II?

Răspunsuri scurte: 1. Ocluzie inversă care cauzează derapaj funcțional, overjet mărit cu risc de traumatism, prevenirea pierderii spațiului, obiceiuri vicioase, Clasa a III-a precoce. **2.** Dacă problema nu se agravează odată cu creșterea și tratamentul poate fi efectuat într-o singură fază, într-un timp mai scurt. **3.** În această perioadă se poate aștepta cel mai mare efect osos al aparatelor funcționale.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 14

Camuflaj sau chirurgie? VTO

Modulul 03

Scopul săptămânii	Să stabilești limitele camuflajului în cazurile scheletice la adulți și când este necesar un consult chirurgical.
Citește în Manual	Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică
Hărți vizuale	46. Hartă Vizuală (Camuflaj sau chirurgie?) · 47. Hartă Vizuală (Obiectiv vizual de tratament (VTO)) · 76. Hartă Vizuală (Când apelăm la chirurgia ortognată?)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Bărbat, 19 ani. Clasa a III-a. ANB −4°, Wits −8 mm. Incisivii inferiori sunt retroînclinați (IMPA 80°), overjet negativ de −3 mm. Pacientul este nemulțumit de profilul său și se plânge că bărbia este prea proeminentă.

Întrebare: Este adecvat camuflajul? Ce opțiuni îi prezinți pacientului?

Comentariu: Deoarece incisivii inferiori sunt deja retroînclinați, există puțin spațiu de manevră pentru camuflaj, iar nemulțumirea pacientului este de natură scheletică și estetică. Se recomandă consultul pentru chirurgie ortognată; planul chirurgical necesită decompensare. Prezinți opțiunile clar, împreună cu limitările previzibile.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care sunt condițiile adecvate pentru camuflaj?
2. De ce este important stadiul creșterii în planificarea chirurgiei?
3. La ce folosește VTO?

Răspunsuri scurte: 1. Discrepanță scheletică ușoară–moderată, profil acceptabil, rezervă de compensare existentă la nivelul incisivilor și așteptări estetice realiste din partea pacientului. **2.** Dacă creșterea este încă activă, rezultatul se poate modifica; în special în Clasa a III-a, așteptăm finalizarea creșterii. **3.** Pentru a anticipa efectul modificărilor planificate asupra profilului și ocluziei; nu reprezintă o garanție a rezultatului exact.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 15

Succesiunea mecanicii și complianța pacientului

Modulul 03

Scopul săptămânii	Să identifici precoce problemele de complianță și să adaptezi planul la o mecanică mai puțin dependentă de cooperarea pacientului.
Citește în Manual	Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică
Hărți vizuale	48. Hartă Vizuală (Succesiunea mecanicii) · 49. Hartă Vizuală (Evaluarea complianței pacientului)

Cazul săptămânii

INTERMEDIAR

Băiat, 15 ani. Ar trebui să poarte elastice de Clasa a II-a. De la ultimele trei controale, relația molară nu s-a modificat; despre purtarea elasticelor spune: „uneori uit".

Întrebare: Ce faci?

Comentariu: Discută deschis despre complianță, fără a acuza, și clarifică din nou obiectivul împreună cu pacientul și familia. Stabilește un plan concret care să faciliteze purtarea. Dacă nu se observă îmbunătățiri, ia în calcul opțiuni mai puțin dependente de cooperare (aparat funcțional fix sau mecanică susținută de mini-implanturi) și documentează planul.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră etapele tipice ale succesiunii mecanicii.
2. Numește două aparate sau mecanici dependente de complianță.
3. Care sunt cei patru pași ai Instrumentului 4?

Răspunsuri scurte: 1. Aliniere–nivelare, faza de lucru (închiderea spațiilor și corecția sagitală), finisare, contenție. **2.** Elastice, aparate funcționale mobilizabile, plăci mobilizabile, aparate extraorale. **3.** Diagnostic → Obiective → Mecanică → Control.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 16

Pacientul adult, cu risc parodontal și multidisciplinar

Modulul 03

Scopul săptămânii	Să planifici condițiile și ordinea echipei multidisciplinare pentru tratamentul ortodontic la pacienți adulți cu risc parodontal.
Citește în Manual	Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică
Hărți vizuale	50. Hartă Vizuală (Planificarea la pacientul adult) · 51. Hartă Vizuală (Pacientul cu risc parodontal) · 52. Hartă Vizuală (Cazuri multidisciplinare: implant și protetică)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Femeie, 42 de ani. A trecut printr-un tratament parodontal, boala fiind în prezent stabilă. La incisivii inferiori se observă o migrare în evantai și diasteme. Primul molar inferior stâng lipsește, fiind planificat un implant.

Întrebare: Ce succesiune urmezi în planificare?

Comentariu: Confirmarea stabilității parodontale cu avizul parodontologului, închiderea spațiilor incisivilor cu forțe ușoare și pregătirea ortodontică a spațiului pentru implant. Poziția și momentul inserării implantului se stabilesc împreună cu echipa. Planul de contenție se întocmește încă de la început.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este condiția pentru începerea tratamentului ortodontic la un pacient parodontal?
2. Implantul se inserează înainte sau după tratamentul ortodontic?
3. Enumeră două aspecte la care trebuie să fii atent la adulți.

Răspunsuri scurte: 1. Boala activă să fie tratată și stabilă, cu monitorizare parodontală regulată. **2.** De regulă, după finalizarea mișcărilor dentare; dacă implantul este folosit pentru ancoraj, îi planificăm poziția în avans, adaptată obiectivului ortodontic. **3.** Lipsa creșterii, suportul parodontal, restaurările și dinții lipsă, obiectivele limitate.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de urmărire

MODULUL 04 · SĂPTĂMÂNILE 17–23

Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi

Această secțiune cuprinde 7 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 04 din Manualul Ortodontului.

Săptămâna 17

Decizia de extracție: indicații și limite

Modulul 04

Obiectivul săptămânii	Să justifici decizia de extracție sau conservare în funcție de înghesuire, profil și poziția incisivilor.
Citește în Manualul Ortodontului	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	Harta Vizuală 53 (Indicațiile extracției) · Harta Vizuală 55 (Limitele tratamentului fără extracții)

Cazul săptămânii

MEDIU

Femeie, 17 ani. Clasa I. Înghesuire de 7 mm sus și 8 mm jos. Protruzie bimaxilară, buzele sunt proeminente și tensionate. Starea parodontală este bună.

Întrebare: Enumeră argumentele pro și contra extracției. Care este decizia ta?

Comentariu: Pro: înghesuire medie-severă, protruzie dentară și labială. Contra: nu există argumente semnificative. Planul cu extracții este un candidat puternic; decizia se ia împreună cu Instrumentul 2 și obiectivul de profil.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră trei argumente în favoarea extracției.
2. Unde este limita tratamentului fără extracții?
3. La un pacient cu profil drept, de ce trebuie analizată cu prudență extracția?

Răspunsuri scurte: 1. Înghesuire severă, protruzie dentară și labială, incisivi la limita osului bazal. **2.** Când nu se poate câștiga spațiu fără o proclinare excesivă a incisivilor și o expansiune dincolo de limitele biologice. **3.** Retracția incisivilor poate aplatiza și mai mult profilul.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de urmărire

Săptămâna 18

Ce dinți extragem?

Modulul 04

Obiectivul săptămânii	Să alegi combinația de extracții în funcție de necesarul de ancoraj și obiectivul final.
Citește în Manualul Ortodontului	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	Harta Vizuală 54 (Opțiuni de extracție a premolarilor) · Harta Vizuală 72 (Extracții în camuflajul Clasei II)

Cazul săptămânii

MEDIU

Fată, 16 ani. Clasa II/1, relație molară de Clasa II completă (o unitate). Overjet 7 mm. Nu există înghesuire în arcada inferioară, iar înclinarea incisivilor inferiori este normală. Creșterea este în mare parte finalizată.

Întrebare: Ce combinație de extracții poate fi luată în considerare? Cum va fi relația molară la final?

Comentariu: Se poate lua în considerare un camuflaj prin extracția exclusivă a primilor premolari superiori. La final, relația molară va fi de Clasa II, iar relația canină de Clasa I. Deoarece nu există necesar de spațiu în arcada inferioară, nu este necesară nicio extracție inferioară.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este principala diferență între extracția a patru premolari și cea a doi premolari superiori?
2. Când poate fi preferată extracția celui de-al doilea premolar inferior în detrimentul primului premolar?
3. Ce instrument deschizi înainte de a lua decizia de extracție?

Răspunsuri scurte: 1. În cazul extracției a doi dinți superiori, arcada inferioară rămâne intactă și finalizăm cu o relație molară de Clasa II; în cazul a patru extracții, urmărim o relație molară de Clasa I. **2.** Dacă dorim o retracție minimă a incisivilor inferiori și obiectivul este deplasarea mezială a molarilor. **3.** Instrumentul 2 / 5 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 19

Protocolul de IPR (stripping)

Modulul 04

Scopul săptămânii	Să diferențiezi când este indicat IPR-ul și când nu, și să planifici cantitatea prin măsurare.
Citește în Manual	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	56. Hartă Vizuală (Protocolul de IPR (stripping))

Cazul săptămânii

MEDIU

Pacientă de 28 de ani. Înghesuire de 3 mm la incisivii inferiori. Coroanele incisivilor au formă triunghiulară, punctele de contact sunt aproape de marginea incizală. Igiena orală este bună, riscul de carie este scăzut.

Întrebare: Este indicat IPR-ul? La ce ești atent?

Comentariu: Opțiune potrivită. Forma triunghiulară a coroanei susține IPR-ul și poate reduce riscul de triunghiuri negre. Planificăm cantitatea prin măsurare, distribuind-o uniform între dinți, respectăm limitele grosimii smalțului și lustruim suprafețele. Luăm în calcul și analiza Bolton.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Numește două situații în care IPR-ul este indicat.
2. Numește două situații în care trebuie evitat IPR-ul.
3. Ce facem cu suprafața dentară după IPR?

Răspunsuri scurte: 1. Înghesuire ușoară–moderată, coroane triunghiulare, discrepanță Bolton, profil care nu permite proclinarea incisivilor. **2.** Risc crescut de carie, igienă orală necorespunzătoare, coroane mici sau înguste, sensibilitate marcată. **3.** Finisăm și lustruim suprafața; reamintim pacientului importanța igienei orale.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 20

Expansiunea transversală și RME

Modulul 04

Scopul săptămânii	Să diferențiezi necesitatea expansiunii dentare versus cea osoasă și să alegi metoda potrivită vârstei.
Citește în Manual	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	57. Hartă Vizuală (Expansiunea arcadei: dentară sau osoasă?) · 58. Hartă Vizuală (Expansiunea rapidă a maxilarului (RME)) · 92. Hartă Vizuală (Limitele gingiei și ale osului în expansiune)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat de 10 ani. Ocluzie inversă posterioară bilaterală. Maxilarul este îngust, bolta palatină este adâncă. Nu există derapaj funcțional. Gingia este sănătoasă.

Întrebare: Ce tip de expansiune este indicat? De ce?

Comentariu: Îngustare transversală osoasă; în perioada de creștere, cât timp sutura este încă deschisă, expansiunea rapidă a maxilarului (RME) este o opțiune potrivită. După expansiune, planificăm o perioadă de contenție.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este diferența dintre expansiunea dentară și cea osoasă?
2. Cum se modifică sutura pe măsură ce vârsta înaintează?
3. De ce este necesară contenția după expansiune?

Răspunsuri scurte: 1. În expansiunea dentară, dinții se înclină vestibular; în cea osoasă, prin deschiderea suturii palatine mediane, baza maxilarului se lărgește. **2.** Se osifică treptat și devine tot mai rezistentă la deschidere. **3.** Zona deschisă are nevoie de timp pentru remodelare; fără contenție, poate apărea recidiva.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 21

Distalizarea, menținătoarele de spațiu și spațiul în dentiția mixtă

Modulul 04

Scopul săptămânii	Să decizi prevenirea pierderii de spațiu sau recuperarea acestuia după pierderea precoce a dinților temporari.
Citește în Manual	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	59. Hartă Vizuală (Distalizarea) · 60. Hartă Vizuală (Menținătoare de spațiu) · 61. Hartă Vizuală (Câștigul de spațiu în dentiția mixtă)

Cazul săptămânii

MEDIU

Fetiță de 9 ani. Al doilea molar temporar inferior stâng a fost extras precoce din cauza cariei. Primul molar permanent inferior stâng a început să se încline mezial. Conform radiografiei panoramice, mai este timp până la erupția premolarului doi care se dezvoltă sub acesta.

Întrebare: Ce faci?

Comentariu: Există riscul pierderii spațiului. Efectuăm analiza spațiului; dacă nu s-a pierdut încă spațiu, luăm în considerare un menținător de spațiu, iar dacă procesul a început deja, evaluăm opțiunile de recuperare a spațiului. Luăm în calcul și gradul de dezvoltare al dintelui subiacent și starea arcadei opuse.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este indicația principală a menținătorului de spațiu?
2. Care este consecința tipică a pierderii precoce a molarilor temporari?
3. Unde se manifestă pierderea ancorajului în timpul distalizării?

Răspunsuri scurte: 1. Pierderea precoce a dintelui temporar, în timp ce mai este timp până la erupția dintelui permanent subiacent. **2.** Migrarea mezială a molarului permanent și pierderea spațiului pentru premolar. **3.** În mișcarea mezială a premolarilor și incisivilor și în proclinația incisivilor.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 22

Ancoraj: TPA, Nance și pierderea ancorajului

Modulul 04

Scopul săptămânii	Să clasifici necesarul de ancoraj la începutul cazului și să identifici precoce pierderea ancorajului.
Citește în Manual	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	11. Hartă Vizuală (Controlul ancorajului) · 65. Hartă Vizuală (Arc transpalatinal și aparat Nance) · 66. Hartă Vizuală (Semnele pierderii ancorajului)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Camuflaj Clasa II cu extracția primilor premolari superiori. În timpul închiderii spațiilor, molarii superiori s-au deplasat mezial cu aproximativ 3 mm, iar overjet-ul a scăzut mai puțin decât era prevăzut. Inițial nu s-a planificat un ancoraj suplimentar.

Întrebare: Care este problema? Ce ar fi trebuit planificat inițial?

Comentariu: Pierderea ancorajului. Acest caz necesita ancoraj maxim; inițial ar fi trebuit planificat un suport de tip TPA sau Nance, ori ancoraj cu mini-implanturi. Acum reevaluăm spațiul restant și obiectivul, adăugând ancoraj suplimentar.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. În ce trei categorii clasificăm necesarul de ancoraj?
2. Numește două semne ale pierderii ancorajului.
3. Care este diferența dintre TPA și Nance?

Răspunsuri scurte: 1. Minim, mediu și maxim. **2.** Migrarea mezială a molarilor, agravarea relației molare, reducerea overjet-ului mai mică decât cea așteptată, înclinarea molarilor. **3.** TPA conectează molarii printr-un arc palatinal; Nance se sprijină pe mucoasa palatului anterior cu un buton acrilic.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 23

Mini-implanturi (TADs)

Modulul 04

Scopul săptămânii	Să enumeri ce trebuie verificat la planificarea inserției mini-implanturilor și care sunt cauzele eșecului.
Citește în Manual	Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi
Hărți vizuale	62. Hartă Vizuală (Zonele de inserție a mini-implanturilor) · 63. Hartă Vizuală (Intruzie cu mini-implant) · 64. Hartă Vizuală (Distalizare cu mini-implant)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Bărbat de 38 de ani. Primul molar superior stâng a suferit o extruzie din cauza pierderii molarului antagonist inferior. Pentru tratamentul protetic este necesar spațiu vertical. Starea parodontală este stabilă.

Întrebare: Ce mecanică poate fi luată în considerare? Ce urmărești la planificare?

Comentariu: Se poate lua în considerare intruzia susținută de mini-implant (adesea cu suport vestibular și palatinal). Evaluăm radiologic distanța dintre rădăcini și cantitatea de os, preferând gingia fixă. Stabilim dimensiunea verticală dorită împreună cu medicul protetician.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Numește două aspecte care trebuie verificate în zona de inserție a mini-implantului.
2. Numește trei cauze ale eșecului mini-implantului.
3. Care este diferența dintre ancorajul direct și cel indirect?

Răspunsuri scurte: 1. Distanța dintre rădăcini, cantitatea de os, gingia fixă, proximitatea structurilor anatomice. **2.** Contactul cu rădăcina, os insuficient, inflamație în jur, încărcare prea timpurie sau excesivă. **3.** La ancorajul direct, forța acționează direct de pe mini-implant; la cel indirect, mini-implantul fixează un dinte, iar forța acționează de pe acel dinte.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

MODULUL 05 · SĂPTĂMÂNILE 24–31

Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III

Această secțiune cuprinde 8 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 05 din Manual.

Săptămâna 24

Clasa II: dentară sau scheletală?

Modulul 05

Scopul săptămânii	Să diferențiezi prin examen clinic și cefalometrie dacă relația molară de Clasa II este de origine dentară sau scheletală.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	12. Hartă Vizuală (Clasa II: dentară sau scheletală?)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat de 12 ani. Relație molară de Clasa II de jumătate de unitate. SNA 83°, SNB 80°, ANB 3°. Incisivii superiori sunt proclinați, profilul este ușor convex.

Întrebare: Această Clasă II este predominant dentară sau scheletală?

Comentariu: Predominant dentară. ANB este în limite normale; relația de Clasa II este explicată de poziția dinților și de proclinația incisivilor superiori. Planul este orientat, în consecință, către mecanici dentoalveolare. Documentează diferențierea cu Instrumentul 4.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră trei parametri pe care îi folosim pentru diferențiere.
2. Cum diferențiezi prognatismul maxilar de retruzia mandibulară?
3. Cu ce instrument verifici rapid diferențierea?

Răspunsuri scurte: 1. ANB și Wits, SNA/SNB, profil, înclinarea incisivilor. **2.** În caz de SNA crescut, componenta maxilară este primară; în caz de SNB scăzut, cea mandibulară; interpretăm împreună cu profilul. **3.** Instrumentul 3 · Detector Vizual Clasa II vs. Clasa III.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 25

Clasa II diviziunea 1 și overjet mărit

Modulul 05

Scopul săptămânii	Să evaluezi riscul de traumatism și necesitatea intervenției timpurii în caz de overjet mărit.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	67. Hartă Vizuală (Clasa II diviziunea 1) · 77. Hartă Vizuală (Overjet mărit și risc de traumatism)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat de 10 ani. Overjet 9 mm. În repaus, buza inferioară se plasează în spatele incisivilor superiori. Acum un an, coroana unui incisiv central superior s-a fracturat. Joacă fotbal.

Întrebare: Ce argumente ai pentru intervenția timpurie?

Comentariu: Overjetul mărit și interpoziția buzei cresc riscul de traumatism; anamneza indică deja un traumatism. Cântărim reducerea timpurie a overjetului (ex. cu aparat funcțional sau fază timpurie). Oferim recomandări privind protecția în timpul sportului.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Ce este interpoziția buzei?
2. Care este riscul principal al overjetului mărit?
3. Care este scopul principal al intervenției timpurii?

Răspunsuri scurte: 1. Buza inferioară ajunge în spatele incisivilor superiori în repaus; aceasta întreține proclinația. **2.** Riscul crescut de traumatism al incisivilor superiori. **3.** Reducerea overjetului și îmbunătățirea relației sagitale prin utilizarea creșterii.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de urmărire

Săptămâna 26

Clasa II diviziunea 2

Modulul 05

Scopul săptămânii	Să stabilești corect secvența tratamentului în Clasa II diviziunea 2 și să evaluezi riscul de recidivă.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	68. Hartă Vizuală (Clasa II diviziunea 2)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Fată de 14 ani. Incisivii centrali superiori sunt retroclinați, cei laterali sunt proclinați. Overbite adânc, incisivii inferiori sunt aproape de gingia palatinală superioară. Linie gingivală înaltă. Relație molară de Clasa II de jumătate de unitate.

Întrebare: Cum stabilești secvența tratamentului?

Comentariu: Corectăm mai întâi înclinarea incisivilor centrali și deschidem ocluzia adâncă; aceasta eliberează mandibula și permite evaluarea corectă a relației sagitale. Controlul torque-ului este important. Din cauza riscului de recidivă a ocluziei adânci, planificăm contenția încă de la început.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este modelul tipic al incisivilor în Clasa II diviziunea 2?
2. De ce începem cu incisivii și ocluzia adâncă?
3. În aceste cazuri, care element este predispus la recidivă?

Răspunsuri scurte: 1. Centrali retroclinați, laterali proclinați și ocluzie adâncă. **2.** Incisivii retroclinați pot bloca mandibula posterior; după corecția lor, relația sagitală poate fi evaluată mai precis. **3.** Ocluzia adâncă și înclinarea incisivilor.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 27

Aparate funcționale: Twin Block și Herbst

Modulul 05

Scopul săptămânii	Să alegi pacientul potrivit și momentul optim pentru un aparat funcțional.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	15. Hartă Vizuală (Aparate funcționale) · 70. Hartă Vizuală (Herbst și aparate funcționale fixe) · 71. Hartă Vizuală (Twin Block)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat de 11 ani. Aproape de vârful de creștere. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Overjet 8 mm. Familia și pacientul sunt cooperanți.

Întrebare: Este acest pacient un candidat potrivit pentru un aparat funcțional?

Comentariu: Da. Clasa II scheletală prin retruzie mandibulară, tiparul vertical normal, proximitatea vârfului de creștere și cooperarea bună sunt condiții favorabile. Alegerea între un aparat mobil sau fix depinde de complianța pacientului și de preferințele acestuia.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este perioada cea mai potrivită pentru un aparat funcțional?
2. Care este diferența practică între un aparat funcțional mobil și unul fix?
3. Care este efectul secundar dentoalveolar tipic?

Răspunsuri scurte: 1. Perioada vârfului de creștere sau proximitatea acestuia. **2.** Aparatul mobil depinde de cooperare; aparatul fix reduce această dependență. **3.** Proclinarea incisivilor inferiori.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 28

Elastice de Clasa II și extracții de camuflaj

Modulul 05

Scopul săptămânii	Să cunoști efectele secundare ale elasticelor de Clasa II și să determini la ce pacienți trebuie limitate.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	69. Hartă Vizuală (Elastice de Clasa II: când da, când nu) · 72. Hartă Vizuală (Extracții în camuflajul de Clasa II)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Fată de 16 ani. Clasa II de o jumătate de unitate. FMA 33°. Incisivii inferiori sunt deja proclinați (IMPA 100°). Tendință ușoară de ocluzie deschisă.

Întrebare: Este indicată utilizarea prelungită a elasticelor de Clasa II? Care sunt alternativele?

Comentariu: Este necesară prudență. Elasticele de Clasa II pot înclina și mai mult incisivii inferiori spre vestibular și pot extruda molarii inferiori; la un pacient hiperdivergent, acest lucru poate duce la rotația posterioară a mandibulei și la agravarea profilului. Ca alternativă, luăm în calcul extracțiile de camuflaj sau mecanica susținută prin mini-implanturi.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră trei efecte secundare ale elasticelor de Clasa II.
2. La ce tip de pacient limităm utilizarea prelungită?
3. La extracțiile de camuflaj, la ce trebuie să fim atenți în timpul retracției incisivilor superiori?

Răspunsuri scurte: 1. Proclinarea incisivilor inferiori, extruzia molarilor inferiori, rotația planului de ocluzie, extruzia incisivilor superiori. **2.** Pacienți hiperdivergenți, cu incisivi inferiori deja proclinați sau cu suport parodontal redus. **3.** Controlul torque-ului; evităm retroclinarea excesivă a incisivilor.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 29

Depistarea precoce a Clasei III și Clasa III pseudo

Modulul 05

Scopul săptămânii	Să diferențiezi Clasa III pseudo de Clasa III reală și să oferi informații precise familiei.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	13. Hartă Vizuală (Clasa III: depistare precoce) · 75. Hartă Vizuală (Clasa III pseudo)

Cazul săptămânii

MEDIU

Fetiță de 7 ani. Ocluzie inversă frontală. În relație centrică, incisivii pot fi aduși în poziție cap-la-cap. În repaus, profilul este drept. Nu există antecedente familiale de Clasa III.

Întrebare: Ce sugerează acest tablou clinic? Ce recomanzi?

Comentariu: Posibilă Clasă III pseudo: contactul cap-la-cap în relație centrică și profilul drept indică o alunecare funcțională anterioară. Luăm în considerare eliminarea precoce a blocajului incisiv și planificăm monitorizarea creșterii.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este principalul semn clinic care diferențiază Clasa III pseudo de cea reală?
2. De ce este importantă anamneza familială?
3. Enumeră trei semne pe care le urmărești în diagnosticul precoce.

Răspunsuri scurte: 1. În cazul unei pseudo-Clase III, incisivii pot fi aduși în poziție cap-la-cap în relație centrică; la cea reală, overjet-ul negativ persistă. **2.** În Clasa III osoasă reală, predispoziția familială este frecventă și influențează prognosticul de creștere. **3.** Diferența RC–CO, profilul (în repaus), înclinarea incisivilor, anamneza familială, relația molară.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 30

Tracțiunea cu mască facială și camuflajul Clasei III

Modulul 05

Obiectivul săptămânii	Să cunoști indicațiile tracțiunii precoce în retruzia maxilară și limitele ce trebuie comunicate familiei.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	Harta vizuală 74 (Tracțiunea cu mască facială) · Harta vizuală 73 (Camuflajul Clasei III)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Băiat de 8 ani. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Overjet negativ −2 mm. Etajul mijlociu al feței pare retruzat. Nu poate fi adus în poziție cap-la-cap în relație centrică.

Întrebare: Ce tratament poți lua în considerare și ce îi comunici familiei?

Comentariu: Clasă III osoasă prin retruzie maxilară; la o vârstă fragedă, se poate lua în considerare tracțiunea cu mască facială (dacă este necesar, împreună cu RME). Familiei îi explicăm clar că, pe parcursul creșterii, poate apărea recidiva și că, ulterior, ar putea fi necesar un camuflaj sau o intervenție chirurgicală.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este perioada ideală pentru masca facială?
2. Cum deplasăm incisivii în camuflajul Clasei III?
3. Ce trebuie neapărat să îi spui familiei?

Răspunsuri scurte: 1. În dentiția mixtă timpurie, cât timp creșterea maxilarului este activă. **2.** Înclinăm incisivii superiori spre vestibular și pe cei inferiori spre lingual (compensație). **3.** Faptul că procesul de creștere poate modifica rezultatul și că pot fi necesare tratamente suplimentare ulterior.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 31

Limita chirurgiei ortognate și corecția relației molare

Modulul 05

Obiectivul săptămânii	Să recunoști semnele care indică necesitatea chirurgiei și să poți explica pacientului conceptul de decompensare.
Citește în Manual	Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III
Hărți vizuale	Harta vizuală 76 (Când alegem chirurgia ortognată?) · Harta vizuală 78 (Corecția relației molare)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Femeie de 20 de ani. ANB 9°, overjet 11 mm, retruzie mandibulară marcată. Discrepanță facială semnificativă. Incisivii inferiori sunt proclinați.

Întrebare: Camuflaj sau chirurgie? Dacă optăm pentru chirurgie, care este pregătirea ortodontică?

Comentariu: Severitatea anomaliei și disconfortul estetic ating limitele camuflajului; se recomandă consultul pentru chirurgie ortognată. Dacă optăm pentru chirurgie, în cadrul pregătirii ortodontice efectuăm decompensarea: aducem incisivii inferiori într-o poziție mai verticală față de osul bazal, motiv pentru care overjet-ul poate crește temporar.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră trei semne care indică necesitatea chirurgiei.
2. Ce este decompensarea?
3. Care sunt cele trei metode de corecție a relației molare?

Răspunsuri scurte: 1. Discrepanță osoasă mare, disconfort estetic marcat, epuizarea rezervelor de compensare a incisivilor, creștere finalizată. **2.** Eliminarea compensării naturale a incisivilor și aducerea lor în înclinația corectă față de osul bazal. **3.** Controlul creșterii, deplasări dentoalveolare (distalizare, elastice), camuflaj prin extracții sau chirurgie.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

MODULUL 06 · SĂPTĂMÂNILE 32–38

Probleme Verticale și Transversale

Această secțiune cuprinde 7 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 06 din Manual.

Săptămâna 32

Ocluzia deschisă: dentară, funcțională, osoasă

Modulul 06

Obiectivul săptămânii	Să diferențiezi tipul de ocluzie deschisă și să elaborezi un plan de tratament orientat pe cauză.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Harta vizuală 4 (Ocluzie deschisă) · Harta vizuală 79 (Ocluzie deschisă: dentară, funcțională, osoasă)

Cazul săptămânii

INTERMEDIAR

Pacientă, 9 ani. Ocluzie deschisă frontală de 3 mm. Obiceiul de sugere a degetului persistă. FMA 26°. Relația molară este Clasa I.

Întrebare: Ce tip de ocluzie deschisă este aceasta? Care va fi primul tău obiectiv?

Comentariu: Tiparul osos vertical este normal; imaginea indică o ocluzie deschisă dentară cauzată de un obicei vicios. Primul obiectiv este renunțarea la obicei; planificăm acest lucru împreună cu familia și copilul, luând în considerare, dacă este necesar, un aparat de reamintire.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care sunt cele trei tipuri de ocluzie deschisă?
2. Care sunt cele două semne ale ocluziei deschise osoase?
3. Cum întrebi despre obiceiurile vicioase?

Răspunsuri scurte: 1. Dentară, funcțională (lingual și cauzată de obiceiuri) și osoasă. **2.** FMA și SN-GoMe crescute, înălțime facială anterioară inferioară mărită. **3.** Întrebi copilul și familia separat, fără a judeca: când, cât de des și în ce situații.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 33

Obiceiuri: sugerea degetului, interpoziția linguală, grilajul lingual

Modulul 06

Obiectivul săptămânii	Să recunoști interpoziția linguală în timpul examinării și, dacă este necesar, să trimiți pacientul către o abordare multidisciplinară.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Hartă vizuală 80 (Sugerea degetului și interpoziția linguală) · Hartă vizuală 81 (Grilaj lingual)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat, 11 ani. În timpul deglutiției, limba este împinsă între incisivi. În vorbire, pronunția sunetului „s" este distorsionată. Ocluzie deschisă frontală de 2 mm.

Întrebare: Cum va arăta planul? Pe cine incluzi în echipă?

Comentariu: Interpoziție linguală și tulburarea de vorbire asociată. Se recomandă o abordare multidisciplinară, în colaborare cu logopedul. Dacă este necesar, luăm în considerare un grilaj lingual. Deoarece riscul de recidivă este ridicat în perioada de contenție, monitorizarea va fi frecventă.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Cum observi interpoziția linguală în timpul examinării?
2. Care este scopul grilajului lingual?
3. De ce este riscul de recidivă ridicat?

Răspunsuri scurte: 1. Roagă pacientul să înghită și, trăgând ușor de buze, observi poziția limbii. **2.** Să împiedice limba să fie împinsă între incisivi și să susțină poziția corectă de repaus a limbii. **3.** Dacă funcția musculară nu se modifică, echilibrul forțelor poate recrea ocluzia deschisă.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 34

Ocluzie adâncă: intruzie sau extruzie?

Modulul 06

Obiectivul săptămânii	În cazul ocluziei adânci, să decizi pe ce grup de dinți acționezi, bazându-te pe vizibilitatea incisivilor și pe tiparul vertical.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Hartă vizuală 5 (Ocluzie adâncă) · Hartă vizuală 82 (Ocluzie adâncă: intruzie sau extruzie?) · Hartă vizuală 83 (Corecția curbei Spee)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Pacientă, 15 ani. Overbite 6 mm. În repaus, vizibilitatea incisivilor superiori este excesivă, iar la zâmbet se observă gingia. FMA 22°. Curba Spee inferioară este accentuată.

Întrebare: Cum deschizi ocluzia adâncă?

Comentariu: Deoarece vizibilitatea incisivilor superiori este excesivă, alegerea primară este intruzia incisivilor superiori. Pentru corecția curbei Spee, se poate planifica intruzia incisivilor inferiori și/sau extruzia dinților posteriori; un tipar apropiat de cel hipodivergent tolerează mai bine extruzia posterioară.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care sunt cele două criterii pe baza cărora decizi?
2. Care sunt cele două metode de corecție a curbei Spee?
3. Ce planifici după tratamentul ocluziei adânci pentru a preveni recidiva?

Răspunsuri scurte: 1. Vizibilitatea incisivilor superiori în repaus și la zâmbet, precum și tiparul vertical. **2.** Intruzia incisivilor și extruzia premolarilor (sau o combinație a celor două). **3.** Înclinarea corectă a incisivilor și contacte incizale adecvate, plan de contenție.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 35

Tipar hiperdivergent și hipodivergent

Modulul 06

Obiectivul săptămânii	Să enumeri mecanicile de evitat și pe cele preferate, bazându-te pe tiparul vertical.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Hartă vizuală 84 (Tipar hiperdivergent) · Hartă vizuală 85 (Tipar hipodivergent) · Hartă vizuală 42 (Tipar vertical: FMA și SN-GoMe)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Băiat de 14 ani. FMA 35°, SN-GoMe 40°. Etaj inferior al feței alungit, incompetență labială. Clasa II pe jumătate de unitate, tendință de ocluzie deschisă.

Întrebare: Ce mecanici eviți în planificare? Ce opțiuni devin prioritare?

Comentariu: Tipar hiperdivergent: evităm mecanicile care cauzează extruzia molarilor (elastice de Clasa II purtate pe termen lung, expansiune necontrolată). Controlul vertical este prioritar; luăm în calcul opțiuni precum intruzia dinților posteriori cu mini-implanturi.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Enumeră două mecanici care trebuie evitate la un pacient hiperdivergent.
2. Ce impact are tiparul hipodivergent asupra tratamentului ocluziei adânci?
3. Care sunt valorile normă clasice pentru FMA și SN-GoMe?

Răspunsuri scurte: 1. Mecanici care cauzează extruzia molarilor: elastice de Clasa II pe termen lung, extruzie posterioară necontrolată. **2.** Tolerează mai bine extruzia posterioară, dar există o predispoziție mai mare pentru ocluzie adâncă și recidivă. **3.** FMA aprox. 25°, SN-GoMe aprox. 32°.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 36

Ocluzie inversă posterioară și ocluzie în foarfecă

Modulul 06

Scopul săptămânii	Diferențierea ocluziei inverse dentare care afectează un singur dinte de îngustarea transversală osoasă.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Hartă vizuală 86 (Ocluzie inversă) · Hartă vizuală 86 (Ocluzie inversă posterioară: compensare sau expansiune?) · Hartă vizuală 88 (Ocluzie în foarfecă)

Cazul săptămânii

INTERMEDIAR

Femeie de 24 de ani. Doar primul molar superior stâng este în ocluzie inversă. Lățimea arcadei superioare este clinic suficientă, dintele în sine este înclinat palatinal.

Întrebare: Această ocluzie inversă este dentară sau osoasă? Cum o corectezi?

Comentariu: Dentară (locală). Lățimea arcadei superioare este suficientă, un singur dinte este înclinat palatinal. Corectăm prin mecanică locală (ex. deplasare vestibulară cu arc sau elastice în cruce); RME nu este necesar. Monitorizăm efectul de extruzie al elasticelor în cruce.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Cum diferențiezi ocluzia inversă posterioară dentară de cea osoasă?
2. Ce este ocluzia în foarfecă?
3. Care este efectul secundar tipic al elasticelor în cruce?

Răspunsuri scurte: 1. Pe baza înclinării dinților și a lățimii arcadei: în forma osoasă, baza maxilarului este îngustă, dinții sunt adesea înclinați vestibular compensator. **2.** Dinții posteriori superiori se închid complet pe partea vestibulară a celor inferiori. **3.** Extruzia dinților.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 37

Ocluzie inversă frontală și derapaj funcțional

Modulul 06

Scopul săptămânii	Evaluarea integrată a spațiului, overbite-ului și a derapajului în cazul ocluziei inverse frontale.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Hartă vizuală 87 (Ocluzie inversă frontală) · Hartă vizuală 89 (Derapaj funcțional)

Cazul săptămânii

INTERMEDIAR

Bărbat de 26 de ani. Doar incisivul lateral superior drept este în ocluzie inversă. Pe arcadă lipsesc aprox. 2 mm pentru lateral. Overbite-ul este normal.

Întrebare: Cum stabilești ordinea corecției?

Comentariu: Mai întâi creăm spațiu pentru lateral, apoi deplasăm incisivul labial. În timpul deplasării, putem lua în calcul o înălțare temporară a ocluziei pentru a elimina obstacolul de închidere. După corecție, un overbite normal ajută la menținerea rezultatului.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Ce verifici prima dată în cazul unei ocluzii inverse frontale?
2. De ce trebuie rezolvată mai întâi lipsa de spațiu?
3. Cum influențează overbite-ul rezultatul?

Răspunsuri scurte: 1. Dacă dintele reprezintă o problemă dentară sau face parte dintr-un tablou osos, și diferența RC–CO. **2.** Fără spațiu, dintele nu poate fi deplasat labial; dacă forțăm, îi împinge pe cei vecini. **3.** Un overbite adecvat ajută la menținerea incisivului corectat în poziție.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 38

Zâmbet gingival, maturitatea suturilor și limitele expansiunii

Modulul 06

Scopul săptămânii	Prezentarea opțiunilor terapeutice în îngustarea transversală la adulți, având în vedere limitele parodontale.
Citește în Manual	Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale
Hărți vizuale	Harta vizuală 90 (Zâmbet gingival) · Harta vizuală 91 (Maturitatea suturilor și vârsta) · Harta vizuală 92 (Limitele gingiei și ale osului în expansiune)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Pacientă, 18 ani. Ocluzie inversă posterioară bilaterală, îngustare transversală osoasă. Fenotip gingival subțire, osul vestibular pare subțire. Premolarii sunt deja înclinați vestibular.

Întrebare: Este adecvată expansiunea pur dentară? Ce opțiuni iei în calcul?

Comentariu: Expansiunea dentară este riscantă: la un fenotip subțire și dinți deja înclinați vestibular, crește riscul de recesiune gingivală și pierdere osoasă. Luăm în calcul expansiunea osoasă asistată de mini-implanturi sau expansiunea chirurgical asistată; solicităm opinia parodontologului.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este riscul expansiunii la un fenotip gingival subțire?
2. De ce este importantă maturitatea suturilor?
3. Enumeră cele patru cauze ale zâmbetului gingival.

Răspunsuri scurte: 1. Recesiune gingivală și pierderea osului vestibular. **2.** Determină fezabilitatea expansiunii osoase și alegerea metodei. **3.** Exces vertical maxilar, extruzie dentoalveolară, buză superioară scurtă sau hiperactivă, erupție pasivă.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat pe fișa de monitorizare

MODULUL 07 · SĂPTĂMÂNILE 39–43

Mecanici Complementare

Această secțiune cuprinde 5 săptămâni. Înainte de a începe, citește pagina introductivă a Modulului 07 din Manual.

Săptămâna 39

Închiderea spațiilor: lanț elastic, mecanică de glisare și de ansă

Modulul 07

Scopul săptămânii	Identificarea pierderii de torque și overbite în timpul închiderii spațiilor și corectarea cauzei.
Citește în Manual	Modulul 07 · Mecanici Complementare
Hărți vizuale	Harta vizuală 93 (Închiderea spațiilor cu lanț elastic) · Harta vizuală 94 (Mecanica de glisare) · Harta vizuală 95 (Mecanica de ansă)

Cazul săptămânii

INTERMEDIAR

Caz cu extracția a patru premolari, faza de închidere a spațiilor. Overbite-ul se adâncește la incisivi, incisivii superiori se verticalizează (pierdere de torque). Se utilizează lanț elastic cu forță mare, secțiunea arcului este mică.

Întrebare: Care este cauza problemei? Ce modifici?

Comentariu: Arc insuficient de rigid și forță prea mare: incisivii se înclină necontrolat spre distal, arcul se deformează. Ne asigurăm că nivelarea este finalizată, trecem la un arc de oțel cu secțiune dreptunghiulară care ocupă mai bine slotul, reducem forța și verificăm torque-ul.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este principala diferență între mecanica de glisare și cea de ansă?
2. Enumeră două semne ale pierderii de torque.
3. Care sunt cele două condiții pentru începerea închiderii spațiilor?

Răspunsuri scurte: 1. În mecanica de glisare, bracketul culisează pe arc (există fricțiune); la ansă, forța și cuplul rezultă din geometria îndoirii arcului. **2.** Verticalizarea incisivilor, adâncirea overbite-ului, înclinarea caninilor și a premolarilor. **3.** Finalizarea nivelării și un arc de lucru dreptunghiular adecvat.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat pe fișa de monitorizare

Săptămâna 40

Controlul torque-ului și al rotației

Modulul 07

Scopul săptămânii	Explicarea motivelor pentru care se pierde rotația și torque-ul și cum pot fi menținute.
Citește în Manual	Modulul 07 · Mecanici Complementare
Hărți vizuale	Harta vizuală 96 (Controlul torque-ului) · Harta vizuală 97 (Corecția rotației)

Cazul săptămânii

INTERMEDIAR

Pacientă, 15 ani. Incisivul lateral superior drept a fost inițial puternic rotat. Corecția este finalizată, familia întreabă: „Se va roti la loc?”

Întrebare: Ce plănuiești pentru a reduce recidiva rotației?

Comentariu: Corectăm rotația în faza timpurie a tratamentului, cu o ușoară supracorecție dacă este necesar, și menținem această poziție până la finalizare. Luăm în calcul un retainer lingual fix pentru contenție. În cazuri selecționate, se poate lua în considerare fibrotomia supracrestală.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este cauza principală a recidivei rotației?
2. Ce influențează exprimarea torque-ului?
3. De ce efectuăm corecția rotației precoce?

Răspunsuri scurte: 1. Reorganizarea lentă a fibrelor gingivale supracrestale. **2.** Jocul dintre arc și slot, dimensiunea și materialul arcului, poziția bracketului. **3.** Cu cât dintele rămâne mai mult în poziția nouă, cu atât contribuie mai mult la stabilitate.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 41

Tracțiunea dintelui inclus

Modulul 7

Obiectivul săptămânii	Să enumeri pregătirea, direcția forței și semnele de alarmă la tracțiunea unui canin inclus.
Citește în Manual	Modulul 7 · Mecanici Auxiliare
Hărți vizuale	Harta vizuală 98 (Tracțiunea dintelui inclus)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Băiat de 13 ani. Caninul superior stâng este inclus palatinal. Pe arcadă există loc pentru canin. Poziția a fost stabilită prin imagistică suplimentară, iar la rădăcinile vecine nu există resorbție.

Întrebare: Ce planifici înainte și în timpul tracțiunii?

Comentariu: Păstrăm spațiul și pregătim o unitate rigidă de ancoraj. După expunerea chirurgicală și aplicarea attachmentului, efectuăm tracțiunea cu forță mică, astfel încât direcția forței să se îndepărteze de rădăcinile vecine. Urmărim progresul prin controale clinice și radiologice periodice.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Numește trei etape de pregătire înainte de tracțiune.
2. De ce este importantă direcția forței?
3. Ce constatări ridică suspiciunea de anchiloză?

Răspunsuri scurte: 1. Spațiu suficient, ancoraj rigid (arc cu secțiune dreptunghiulară sau sprijin suplimentar), poziție 3D precisă, plan comun cu chirurgul. **2.** Dacă forța este orientată spre rădăcinile vecine, crește riscul de resorbție radiculară. **3.** Lipsa deplasării o perioadă mai îndelungată, iar dinții de ancoraj se intruzează; detalii: Ghidul 4 · Traumă și Anchiloză.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 42

Verticalizarea molarilor, arcul lingual, quad helix și pendulum

Modulul 7

Obiectivul săptămânii	Să compari într-un tabel indicațiile și efectele secundare ale aparatelor auxiliare.
Citește în Manual	Modulul 7 · Mecanici Auxiliare
Hărți vizuale	Harta vizuală 99 (Verticalizarea molarilor) · Harta vizuală 100 (Arcul lingual și quad helix) · Harta vizuală 101 (Aparatul pendulum)

Cazul săptămânii

MEDIU

Bărbat de 45 de ani. Primul molar inferior stâng lipsește de multă vreme. Al doilea molar inferior stâng este înclinat mezial. Se planifică deschiderea spațiului pentru un implant.

Întrebare: Ce mecanică vine în discuție? Ce efect secundar urmărești?

Comentariu: Prin verticalizarea molarului putem deschide spațiu pentru implant, iar starea parodontală a suprafeței radiculare distale se poate îmbunătăți. În timpul verticalizării urmărim extruzia molarului și contactele ocluzale. Starea parodontală și obiectivul comun cu implantologul le clarificăm încă de la început.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este efectul secundar tipic al verticalizării molarului?
2. Când folosim quad helixul?
3. Cum se manifestă pierderea ancorajului la pendulum?

Răspunsuri scurte: 1. Extruzia molarului și contactul ocluzal precoce. **2.** Când în arcada superioară este nevoie de o expansiune dentoalveolară ușoară–moderată și de derotația molarilor. **3.** În migrarea mezială a premolarilor și incisivilor, în proclinarea incisivilor; la molari, în înclinarea distală.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 43

Extruzia, arcurile de intruzie și tipurile de elastice

Modulul 7

Obiectivul săptămânii	Să explici indicația extruziei ortodontice și efectele secundare ale arcurilor de intruzie.
Citește în Manual	Modulul 7 · Mecanici Auxiliare
Hărți vizuale	Harta vizuală 102 (Mecanica extruziei) · Harta vizuală 103 (Arcuri de intruzie) · Harta vizuală 104 (Tipurile și forțele elasticelor)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Femeie de 30 de ani. Fractură coronară la incisivul central superior drept, extinsă sub gingie. Lungimea rădăcinii este suficientă, tratamentul de canal a fost efectuat. Protezistul solicită un contur restaurator sănătos.

Întrebare: Cum poate contribui ortodonția? La ce trebuie să fii atent?

Comentariu: Prin extruzie ortodontică (erupție forțată), linia de fractură poate fi adusă deasupra gingiei. Amploarea obiectivului o stabilim împreună cu protezistul, urmărim raportul rădăcină–coroană, planificăm timpul de contenție în noua poziție; la nevoie, includem și o corecție parodontală.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este indicația tipică a extruziei ortodontice?
2. Care sunt cele două efecte secundare ale arcului de intruzie?
3. Care sunt cele două criterii la alegerea elasticului?

Răspunsuri scurte: 1. Expunerea marginii restaurării în cazul unei fracturi sau carii extinse sub gingie. **2.** Proclinarea incisivilor și înclinarea distală/extruzia molarilor. **3.** Forța dorită și distanța de întindere a elasticului; în plus, cooperarea pacientului.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat în fișa de monitorizare

MODULUL 8 · SĂPTĂMÂNILE 44–48

Finisare și Stabilitate

Această parte cuprinde 5 săptămâni. Înainte de a începe, citește în Manual pagina introductivă a Modulului 8.

Săptămâna 44

Lista de verificare a finisării și repoziționarea bracketților

Modulul 8

Obiectivul săptămânii	Să parcurgi complet lista de verificare a finisării înainte de îndepărtarea bracketților.
Citește în Manual	Modulul 8 · Finisare și Stabilitate
Hărți vizuale	Harta vizuală 105 (Lista de verificare a finisării) · Harta vizuală 106 (Repoziționarea bracketului)

Cazul săptămânii

MEDIU

Luna a 22-a de tratament. Nivelul crestelor marginale diferă între regiunea caninului drept și a celui stâng. Pe radiografia panoramică, rădăcina incisivului lateral superior drept este înclinată distal. Pacientul ar dori ca bracketii să fie îndepărtați cât mai curând.

Întrebare: Ce faci înainte de îndepărtarea bracketților?

Comentariu: Parcurgem lista de verificare a finisării. Din cauza diferenței dintre crestele marginale și a înclinării radiculare, repoziționăm bracketii implicați și planificăm o scurtă fază de finisare. Îi explicăm pacientului pe scurt și clar de ce este necesar acest pas pentru ca rezultatul să fie durabil.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Numește cinci puncte din lista de verificare a finisării.
2. Când trebuie efectuată repoziționarea bracketților?
3. De ce este importantă nivelarea crestelor marginale?

Răspunsuri scurte: 1. Relația molară și canină, overjet și overbite, liniile mediane, crestele marginale, paralelismul radicular, contactele, planul ocluzal, torque. **2.** În timpul nivelării sau înainte de finisare, imediat ce observăm problema; nu trebuie lăsată pentru final. **3.** Pentru contacte corecte, sănătate parodontală și ocluzie echilibrată.

☐ Am citit ☐ Am rezolvat cazul ☐ Am răspuns la cele 3 întrebări ☐ Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 45

Paralelismul radicular și linia mediană

Modulul 8

Obiectivul săptămânii	Să identifici cauza deviației liniei mediane și să alegi mecanica potrivită la finisare.
Citește în Manual	Modulul 8 · Finisare și Stabilitate
Hărți vizuale	Harta vizuală 107 (Paralelismul radicular) · Harta vizuală 108 (Finisarea liniei mediane) · Harta vizuală 10 (Deviații ale liniei mediane)

Cazul săptămânii

MEDIU

Caz cu patru extracții de premolari, fază de finisare. Linia mediană superioară coincide cu linia mediană facială. Linia mediană inferioară este deviată cu 2 mm spre dreapta. Nu există asimetrie osoasă.

Întrebare: Cum cauți cauza? Ce mecanică vine în discuție?

Comentariu: Mai întâi caută cauza: închiderea asimetrică a spațiilor, înghesuire mai mare pe o parte sau deplasare funcțională. Dacă nu există asimetrie osoasă, se poate face o corecție dentară cu mecanică asimetrică sau cu elastice asimetrice. Paralelismul radicular îl verificăm pe radiografia panoramică și clinic.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Numește trei cauze ale deviației liniei mediane.
2. Pe care trebuie să o excluzi prima?
3. La ce suntem atenți când verificăm paralelismul radicular?

Răspunsuri scurte: 1. Dentară (înghesuire asimetrică, dinte lipsă), deplasare funcțională, asimetrie osoasă. **2.** Deplasarea funcțională și asimetria osoasă. **3.** La faptul că radiografia panoramică poate distorsiona; evaluăm împreună cu examenul clinic și, la nevoie, cu imagistică suplimentară.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 46

Așezarea ocluzală (settling) și alegerea contenției

Modulul 8

Obiectivul săptămânii	Să planifici la finisare îmbunătățirea contactelor posterioare și alegerea contenției potrivite pacientului.
Citește în Manual	Modulul 8 · Finisare și Stabilitate
Hărți vizuale	Harta vizuală 109 (Așezarea ocluzală (settling)) · Harta vizuală 110 (Alegerea contenției)

Cazul săptămânii

MEDIU

Băiat de 17 ani. Fază de finisare. Relațiile incisivilor sunt bune, dar în regiunea premolarilor contactele posterioare sunt slabe. Igiena orală este medie, cooperarea este bună.

Întrebare: Cum îmbunătățești contactele posterioare? Pe ce criterii alegi contenția?

Comentariu: Pentru settling se pot folosi un arc de finisare mai flexibil sau elastice verticale purtate pentru scurt timp. Contenția o alegem în funcție de tipul problemei inițiale, riscul de recidivă, igiena orală și cooperarea pacientului; detalii: Ghidul 2 · Manualul de Contenție Ortodontică.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care sunt cele două metode folosite pentru settling?
2. Numește trei criterii pentru alegerea contenției.
3. În ce material găsești detaliile despre contenție?

Răspunsuri scurte: 1. Arc de finisare flexibil sau segmentat și elastice verticale purtate pentru scurt timp. **2.** Problema inițială, riscul de recidivă, igiena orală, cooperarea, preferința pacientului. **3.** Ghidul 2 · Manualul de Contenție Ortodontică.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 47

Retainer lingual fix, Hawley și gutieră transparentă

Modulul 8

Obiectivul săptămânii	Să explici pacientului în două minute avantajele și dezavantajele opțiunilor de contenție.
Citește în Manual	Modulul 8 · Finisare și Stabilitate
Hărți vizuale	Harta vizuală 111 (Retainer lingual fix) · Harta vizuală 112 (Hawley și gutieră transparentă) · Harta vizuală 20 (Contenție și recidivă)

Cazul săptămânii

BAZĂ

Fată de 16 ani. Inițial erau prezente diastemă superioară și rotații ale incisivilor inferiori. Igiena orală este medie. Vine regulat la controale.

Întrebare: Ce contenție recomanzi? Ce îi spui pacientei?

Comentariu: Diastema și rotațiile prezintă risc de recidivă; se recomandă un retainer lingual fix, completat la nevoie cu un aparat mobil purtat noaptea. Îi explicăm pacientei importanța igienei și a controalelor regulate și subliniem că un punct de lipire desprins trebuie observat și semnalat imediat.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care sunt cele două indicații ale retainerului lingual fix?
2. Care este un avantaj al Hawley?
3. Care este un dezavantaj al gutierei transparente?

Răspunsuri scurte: 1. Diastemă sau rotații marcate la început, înghesuire incisivă inferioară. **2.** Se poate reajusta și permite așezarea ocluzală. **3.** Depinde de cooperare și se uzează în timp, putând necesita înlocuire.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 48

Cauzele recidivei și monitorizarea pe termen lung

Modulul 8

Obiectivul săptămânii	Să analizezi un caz recidivat fără a învinui pe nimeni și să discuți cu pacientul un plan nou.
Citește în Manual	Modulul 8 · Finisare și Stabilitate
Hărți vizuale	Harta vizuală 113 (Cauzele recidivei) · Harta vizuală 114 (Monitorizarea pe termen lung)

Cazul săptămânii

MEDIU

Femeie de 21 de ani. La trei ani după încheierea tratamentului, înghesuirea incisivilor inferiori a reapărut. Pacienta spune că în urmă cu un an a încetat să poarte aparatele mobile.

Întrebare: Care sunt cauzele posibile ale recidivei? Ce faci?

Comentariu: Neglijarea contenției și modificările fiziologice care continuă odată cu vârsta. Reevaluăm situația, comparăm documentația inițială cu cea finală. În cazul unei înghesuiri ușoare, tratamentul limitat și planul de contenție pe termen lung care urmează le discutăm împreună cu pacienta.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Numește trei cauze ale recidivei.
2. Ce planificăm în monitorizarea pe termen lung?
3. Cum explicăm pacientului contenția?

Răspunsuri scurte: 1. Neglijarea contenției, creșterea care continuă și modificările legate de vârstă, tensiunea fibrelor parodontale, funcția musculară, o finisare nesatisfăcătoare. **2.** Control la intervale stabilite, starea retainerului, igiena. **3.** Ca parte a tratamentului, chiar de la început; în limbaj simplu, spunând că dinții au tendința de a se deplasa pe tot parcursul vieții.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

MODULUL 9 · SĂPTĂMÂNILE 49–52

Cazuri Clinice Comentate

Această parte cuprinde 4 săptămâni. Înainte de a începe, citește în Manual pagina introductivă a Modulului 9.

Săptămâna 49

Caz comentat: înghesuire la adult

Modulul 9

Obiectivul săptămânii	Să planifici un caz de înghesuire la adult de la început până la sfârșit, de la lista de probleme până la contenție.
Citește în Manual	Modulul 9 · Cazuri Clinice Comentate
Hărți vizuale	Harta vizuală 115 (Caz: înghesuire la adult)

Cazul săptămânii

MEDIU

Femeie de 32 de ani. Clasa I, înghesuire de 5 mm la incisivii inferiori și de 2 mm sus. Profil drept. Fenotip gingival subțire, igienă orală bună. Plângere: „Dinții mei de jos sunt tot mai înghesuiți.”

Întrebare: Descrie lista de probleme, obiectivele și opțiunile mecanice.

Comentariu: Problemă: înghesuire moderată inferioară și ușoară superioară, fenotip subțire. Obiectiv: alinierea incisivilor fără proiectare excesivă, păstrând suportul parodontal. Mecanică: un plan fără extracții, cu IPR și remodelare limitată a arcadei, poate fi luat în considerare. Contenție: retainer lingual fix și monitorizare pe termen lung.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. De ce limităm proclinarea incisivilor la un profil drept?
2. La ce mișcare trebuie să fim atenți în cazul fenotipului subțire?
3. De ce planificăm contenție pe termen lung în acest caz?

Răspunsuri scurte: 1. Din punctul de vedere al profilului și al suportului parodontal, există o limită a proiectării incisivilor. **2.** La mișcarea vestibulară a incisivilor și la expansiune. **3.** La adult, tendința înghesuirii de a progresa odată cu vârsta persistă.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 50

Cazuri comentate: Clasa a II-a în perioada de creștere și Clasa a III-a precoce

Modulul 9

Obiectivul săptămânii	Să compari două cazuri opuse, aflate în perioada de creștere, folosind aceeași structură a listei de probleme.
Citește în Manual	Modulul 9 · Cazuri Clinice Comentate
Hărți vizuale	Harta vizuală 116 (Caz: Clasa a II-a diviziunea 1 în perioada de creștere) · Harta vizuală 117 (Caz: Clasa a III-a precoce)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Cazul A: băiat de 11 ani. Clasa a II-a diviziunea 1, overjet 8 mm, ANB 6°, FMA 25°, cooperare bună. Cazul B: fată de 8 ani. Ocluzie inversă frontală, ANB −2°, SNA 78°, în relație centrică nu poate fi adusă cap la cap, iar în anamneză tatăl are Clasa a III-a.

Întrebare: Descrie pentru ambele cazuri lista de probleme și decizia privind momentul tratamentului.

Comentariu: A: Clasa a II-a osoasă prin retruzie mandibulară, tipar vertical normal, aproape de vârful de creștere; se poate lua în considerare un tratament cu aparat funcțional în perioada de creștere. B: Clasa a III-a osoasă predominant prin retruzie maxilară, predispoziție familială; se poate lua în considerare protracția precoce, iar familiei îi comunicăm posibilitatea recidivei și a unui tratament suplimentar ulterior.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este criteriul de decizie comun celor două cazuri?
2. Ce trebuie spus neapărat familiei în cazul B?
3. Ce efect secundar urmărim în cazul A?

Răspunsuri scurte: 1. Faptul că perioada de creștere oferă posibilitatea tratamentului. **2.** Că odată cu creșterea poate apărea recidivă și că ulterior poate fi nevoie de camuflaj sau de intervenție chirurgicală. **3.** Proclinarea incisivilor inferiori.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 51

Cazuri comentate: ocluzie deschisă prin obicei și asimetrie

Modulul 9

Obiectivul săptămânii	În cazurile în care sunt prezente împreună o problemă verticală și una transversală, să separi mai întâi cauza.
Citește în Manual	Modulul 9 · Cazuri Clinice Comentate
Hărți vizuale	Harta vizuală 118 (Caz: ocluzie deschisă prin obicei) · Harta vizuală 119 (Caz: asimetrie și linie mediană)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Cazul A: fată de 10 ani. Ocluzie deschisă frontală de 4 mm cauzată de sugerea degetului, maxilar superior îngust, fără ocluzie inversă posterioară. Cazul B: băiat de 15 ani. Linia mediană inferioară este deviată cu 3 mm spre stânga, nu se modifică în relație centrică, iar și bărbia deviază spre stânga.

Întrebare: Ce separi mai întâi la fiecare caz și care va fi planul?

Comentariu: A: ocluzie deschisă dentară prin obicei; mai întâi renunțarea la obicei, apoi evaluarea constricției transversale, la nevoie expansiune și planificarea sprijinirii poziției limbii. B: deviația care nu se modifică în relație centrică și care implică și bărbia indică o asimetrie osoasă; o evaluăm cu imagistică suplimentară și monitorizarea creșterii, iar un consult chirurgical poate deveni necesar.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Ce constatare indică faptul că deviația liniei mediane are origine osoasă?
2. Ce se întâmplă dacă începem mecanica înainte de renunțarea la obicei?
3. De ce urmărim creșterea într-un caz asimetric?

Răspunsuri scurte: 1. Nu se corectează în relație centrică, iar bărbia urmează deviația. **2.** Crește riscul de recidivă, iar tratamentul se prelungește. **3.** Asimetria se poate accentua în timpul creșterii; momentul deciziei depinde de aceasta.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Săptămâna 52

Caz comentat: analiza unui tratament prelungit

Modulul 9

Obiectivul săptămânii	Să analizezi sistematic un tratament prelungit, să întocmești un plan nou și să închei anul.
Citește în Manual	Modulul 9 · Cazuri Clinice Comentate
Hărți vizuale	Harta vizuală 120 (Caz: analiza unui tratament prelungit)

Cazul săptămânii

AVANSAT

Fată de 17 ani. Tratamentul planificat pentru 20 de luni se află în luna a 30-a. Spațiile de extracție nu s-au închis complet, molarii au migrat mezial mai mult decât se aștepta, iar în ultimele șase luni au fost ratate două controale. La început nu a fost întocmit un plan de ancoraj.

Întrebare: Enumeră cauzele prelungirii tratamentului și scrie planul nou.

Comentariu: Cauze: lipsa planului de ancoraj și pierderea ancorajului, controalele neregulate, omiterea evaluărilor intermediare. Plan nou: rediagnosticare cu documentație actualizată, fixarea din nou a spațiului rămas și a obiectivului, la nevoie ancoraj cu mini-implant, un plan clar de timp și de cooperare cu pacienta. Cu Instrumentul 5 marchează greșelile pe rând.

AUTOEVALUARE · 3 ÎNTREBĂRI

1. Care este primul pas la un tratament prelungit?
2. Care greșeală de planificare a fost decisivă în acest caz?
3. Ce instrument ușurează această analiză?

Răspunsuri scurte: 1. Rediagnosticarea cu documentație actualizată și reformularea obiectivelor. **2.** Faptul că la început nu a fost întocmit un plan de ancoraj. **3.** Instrumentul 5 · Radarul Greșelilor de Planificare.

- [ ] Am citit
- [ ] Am rezolvat cazul
- [ ] Am răspuns la cele 3 întrebări
- [ ] Am bifat în fișa de monitorizare

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și avizul medicului specialist.

Pasul următor

Ai ajuns la capătul celor 52 de săptămâni? Mai întâi revino la săptămânile rămase goale în Fișa Săptămânală de Progres.

Apoi deschide materialul **100 de întrebări de caz comentate** și rezolvă fiecare bloc contra cronometru. Pentru săptămânile în care cefalometria a mers greu, parcurge cele 10 exerciții din **Caietul de exerciții de măsurare cefalometrică**.

La începutul celui de-al doilea an, reia cu propriile cazuri partea **Modulul 9 · Cazuri Clinice Comentate** din Manual și materialul **Instrumentul 5 · Radarul Greșelilor de Planificare**.